EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL : HOSPITAL DE SAN CARLOS
N° EGRESO : 84901
SERVICIO : MEDICINA HSC
FECHA : 2024-05-20 13:09:00

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: CARLOS JOSE MEWES BARRIENTOS			**RUN**	: 11.834.078-7
F.Nac	: 06-10-1971	**Edad**	: 52 AÑOS, 7 MESES	**Género**	: Masculino
Dirección	: CHACABUCO 219			**Comuna**	: SAN CARLOS
Previsión	: FONASA B	**Teléfono**	: 0		
Fecha Ingreso	: 2024-05-17	**Fecha Egreso**	: 2024-05-20 13:09:00	**Causal**	: MEDICA
Condición	: VIVO	**Destino**	: HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA	**Derivación**	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. N39.0-INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

1) ITU en tratamiento
2) Sd hiperglicemico en vias de resolucion
3) Sd de Down
4) Hipotiroidismo
5) Dm2 IR

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. R73.9-HIPERGLICEMIA, NO ESPECIFICADA (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

Paciente con antec descritos, acude por cuadro De Tos De 3 Dias De Evolución, Hace 2 Dias Con Fiebre, Hoy Desatura En Domicilio.
A Su Llegada HGT HI. Se Apoya Con Fio2 Por MAF, Con Posterior Titulacion, Actualmente Con Fio2 Amb Sat 98%.
Examenes Destaca: Panel Viral Abreviado (-), Glicemia 564, Crea 1.1, Lactato 1.7, PCR 230, Uremia 59, ELP 128/5/98, GB 14100, Hb 12.2, Plaquetas 267000, INR 1.43, EOC Turbia, Nitritos (+), Leuco 25-25, Piocitos 50-60 X Campo/Placas De Pus Regular Cantidad. GSA Ph 7.37, Po2 83, Pco2 31, HCO3 18.4, PAFI 348. Osmolaridad: 311. Se Maneja Con Hidratacion Ev + BIC De Insulina Con Franca Mejoría De Los Síntomas Se Hospitaliza Para Monitorización

Paciente HDN estable, personal de enfermeria refeire que ha paso buena noche, sin episodios de nauseas y/o vomitos, con buena toelrancia a alimetnacion VO, peak febril registrado de 38,2°C a las 21 hrs, diuresis registrada de 700 cc durante la noche, deposiciones (-).

URC con desarrollo de K Pneumoniae sensible a ertapenem, meropenem, pip/tazo, imipenem, gentamicina,

Ex de lab 18/05 -> crea 0,9; lactato 1,3; PCR 83,9; uremia 59; Na/K/Cl 138/4.8/108; Gb 9,3; Hb/HCto 12.2/36; plaq 266000; segment 82%; INR 1,4;

Ex fisico -> Vigil, CLOTE, mucosas rosadas, levemente deshidratadas (menos en comparativa a evaluacion previa), llene capilar < 2 segs
CardiacO RR2T NAS
Pulmonar MP (+) SRA

Abdomen BDI, RHA (+), sin megalias, sin signos de irritacion peritoneal
Extremidades sin edema, sin signos de TVP

PLAN DE MANEJO:

1) HDN: Estable, sin conflicto
2) Ventilatorio: Estable, sin conflicto
3) Infeccioso: Con parametros inflamatorios en descenso, se solicitara nuevo control ahora, en caso de estabilidad, se procedera a continuar hospitalizacion via HODOm

INDICACIONES AL ALTA

1. Reposo relativo
2. Regimen diabetico hiposodico a tolerancia
3. Ertapenem 1 gr al dia EV por 5 dias
4. Insulina lantus 12 UI AM SC
5. Omeprazol 20 mg al dia VO por 5 dias
6. Metamizol 300 mg c/!2 hrs VO por 5 dias
7. KNT motora dos veces al dia
8. Examenes de control 23/05

DANIEL EDUARDO ACEVEDO PEREIRA
MEDICO TRATANTE
18431829-6

JEFE SERVICIO